

a1_caa_hub 测试报告

生成时间：2026-05-08 20:05:18

测试时间：2026-05-08 20:05:18

- 一、测试目的：验证工具增强对输出质量提升作用。
- 二、测试内容：同一输入下，分别运行 use_tools=True/False。
- 三、测试方法：对比输出结构与长度，核对产物路径。
- 四、测试过程：
 - 1) 启用工具运行；
 - 2) 禁用工具运行；
 - 3) 指标对照；
 - 4) 结论归纳。
- 五、测试结果：

启用工具 success=True chars=1688 markers=27

禁用工具 success=True chars=1650 markers=21

工具说明：tool_老人主体:tool_老人主体：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_近况摘要:tool_近况摘要：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_风险洞察:tool_风险洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_照护洞察:tool_照护洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_体征洞察:tool_体征洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_用药洞察:tool_用药洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_照护服务记录:tool_照护服务记录：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_健康评估记录:tool_健康评估记录：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_睡眠记录:tool_睡眠记录：从长者智能计算图提取历史参考证据

六、结论：工具可显著提升智能体输出准确性、完整性与专业性，助力机构提供更精准照护与医疗服务。

【启用工具输出摘录】

照护协作建议报告：陈萍忠女士（失智合并近期头部外伤）

一、问题归纳

1. ****行为与依从性问题****：老人存在阿尔茨海默病性痴呆相关BPSD症状，明确拒绝传统康复训练，但日常喜好跳舞。
2. ****安全风险突出****：近期发生右额部皮下血肿（头部外伤），既往有夜间如厕跌倒史，反复出现无明确原因的皮肤擦伤/淤青，提示跌倒与环境碰撞风险高。
3. ****照护执行难点****：非药物干预难以落实，家属高度关注但存在长期焦虑，可能影响照护协同。
4. ****健康管理重点****：需确保规律服药（含认知症药物及镇静类药物）、监测心率（起搏器携带者）、预防再次外伤。

二、处理步骤（贴合喜好、可执行）

（1）将“跳舞”转化为结构化非药物干预

- ****每日安排15-20分钟音乐律动活动****：选择老人熟悉的上海老歌或轻快民乐，由照护员陪伴在安全区域（如防滑地板、无障碍空间）进行简单踏步、摆臂等动作。

- ****替代传统康复训练****：不再强调“训练”字眼，改称“一起跳舞时间”，利用其内在

动机提升参与意愿。

- **频率与时长**：建议上午10:00及下午15:00各一次，避开服药后嗜睡时段（如晚间奥氮平、劳拉西泮服用后）。
- **安全措施**：活动区域移除尖锐家具，铺设防滑垫，照护员全程近距离陪伴，避免快速旋转或跳跃动作。

（2）强化跌倒与外伤防护

- **夜间如厕全程陪护**：鉴于既往夜间跌倒史，无论老人是否主动要求，均需照护员协助如厕，使用床边坐便椅可降低行走风险。
- **环境安全再排查**：检查走廊、卫生间、卧室是否存在突出物、门槛或光线不足，确保夜间感应灯全覆盖。
- **穿着建议**：穿防滑软底鞋，避免拖鞋；衣裤合身，防止绊倒。

（3）规范服药管理

- **固定服药时间与流程**：将药物按早、晚分装于药盒，由同一照护员在固定时间递送，配合温水，确认吞咽完成。
- **避免重复记录干扰判断**：核对实际用药清单（多奈哌齐、美金刚、瑞舒伐他汀、奥氮平、劳拉西泮等），确保系统记录与实物一致，防止因录入错误误判依从性。
- **观察药物副作用**：特别注意劳拉西泮、奥氮平可能导致的嗜睡、步态不稳，若活动后明显乏力，及时反馈医生评估剂量。

三、风险防护要点

风险类型	防护措施
----- -----	
跌倒/外伤	
夜间如厕必陪护；活动区无尖锐物；防滑鞋+防滑垫；避免单独行走	
皮肤损伤	每日检查四肢及头部有无新发淤青/擦伤；记录部位与可能诱因
心动过缓	
每日至少2次监测心率（晨起、午后），若持续<55次/分或出现头晕，立即报告	
BPSD激越	
避免强迫训练；用跳舞、听戏等正向活动转移注意力；保持环境安静	

四、家属沟通建议

- *

【禁用工具输出摘录】

照护协作专业答复报告
长者姓名：陈萍忠
核心问题：失智伴BPSD、拒绝康复训练、跌倒高风险、服药依从性需保障、家属焦虑显著

一、问题归纳

1. 老人有阿尔茨海默病性痴呆，存在行为与精神症状（BPSD），表现为拒绝配合结构化

康复训练。

2. 近期有头部外伤史（右额部皮下血肿），叠加失智与起搏器植入史，跌倒风险极高。
3. 日常喜好跳舞，可作为非药物干预的切入点。
4. 家属照护关注度高但伴随长期焦虑，需建立信任与协同机制。
5. 需确保规律服药（尤其心脏起搏器相关及认知症药物）并落实安全防护。

二、处理步骤（贴合喜好的可执行干预）

（1）将“跳舞”转化为安全认知-体能融合活动

- **每日安排15–20分钟音乐律动时间**：选择老人熟悉的上海老歌或轻快民乐，鼓励站立扶椅摆动、踏步或手部舞动。避免快速旋转或跳跃动作。
- **替代传统康复训练**：将平衡练习融入舞蹈动作（如单脚站立扶椅数拍、缓慢转身），由照护员同步示范，以“一起跳舞”名义引导参与，避免使用“训练”字眼。
-
- **时段选择**：安排在老人情绪平稳时段（如上午9–10点），避开午后易激惹时段。

（2）服药管理嵌入日常节奏

- **服药与舞蹈关联**：在舞蹈活动前/后固定时间给药，形成“跳舞—吃药—休息”正向循环。例如：“跳完这支舞，我们一起吃药，然后喝茶休息。”
- **使用分装药盒+视觉提示**：药盒标注“跳舞后服用”，放置于活动区域显眼处，减少遗忘。

（3）BPSD非药物干预策略

- 当老人拒绝参与时，不强行劝说，改为邀请式语言：“阿姨，这支曲子您以前跳得可好了，要不要试试？”
- 若出现烦躁，立即暂停，转为舒缓音乐+轻柔按摩手部，重建安全感。

三、风险防护

跌倒预防（重点！）

- **环境安全**：
 - 舞蹈区域清除障碍物，铺设防滑地垫，四周安装扶手或稳固椅子供随时抓握。
 - 确保照明充足，尤其黄昏时段。
- **行为监护**：
 - 活动全程照护员一对一陪伴，保持半臂距离可及时支撑。
 - 穿防滑鞋，避免穿拖鞋或袜子直接行走。
- **头部外伤后特别注意**：观察是否有头晕、步态不稳加重，如有异常立即暂停活动并报告医护。

用药安全

- 核对起搏器用药（如抗凝药）是否按时服用，避免漏服导致血栓风险。
- 记录每次服药反应，尤其注意是否有晕眩、乏力等可能增加跌倒风险的副作用。

四、家属沟通建议

- **主动传递积极进展**：每日向家属简要反馈“今天陈阿姨跟着《茉莉花》音乐摆手笑了”“顺利完成了”